

หัวข้อสัมมนา

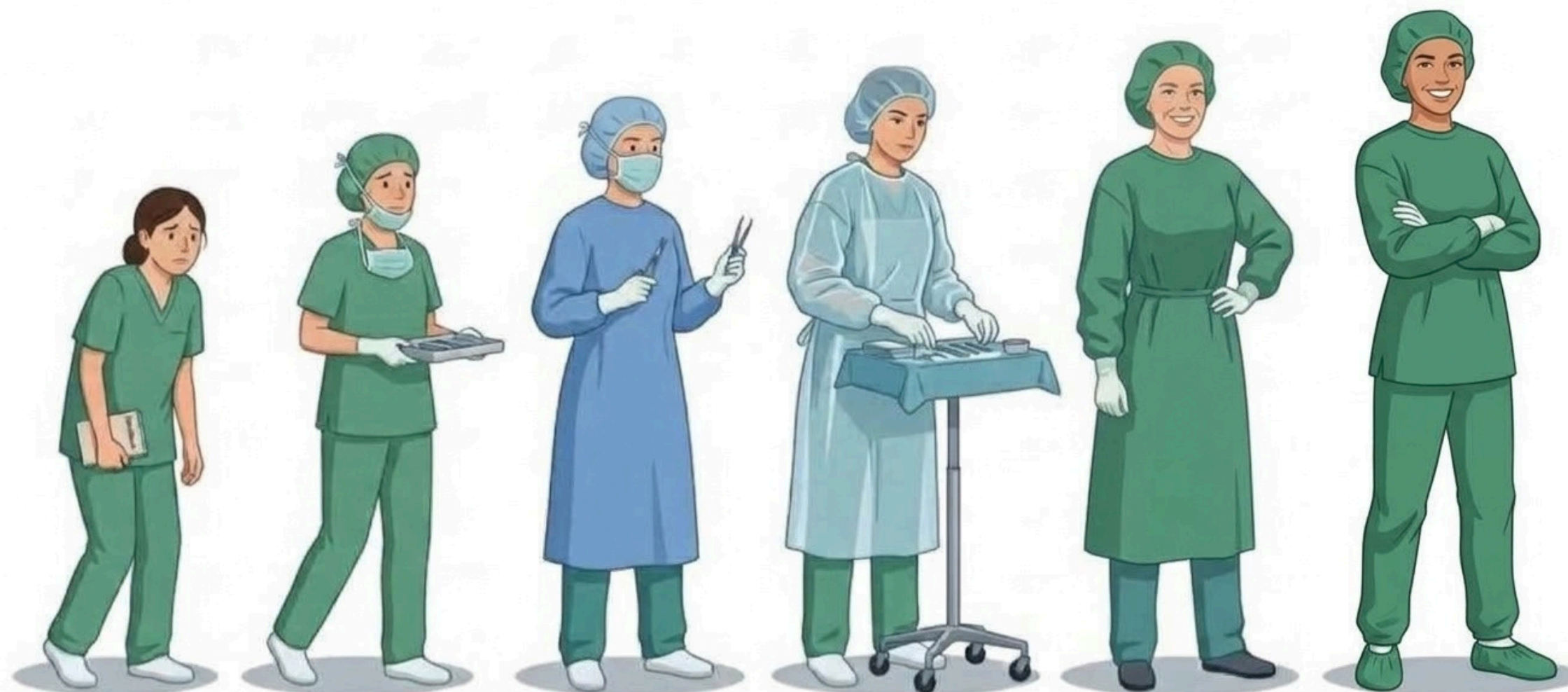
รูปแบบการนิเทศงานพยาบาลจบใหม่ในห้องผ่าตัด

โดย
กลุ่มที่ 6

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม รุ่น 55
ปีการศึกษา 2569



“จากวันแรก...สู่ความมั่นใจ การพัฒนาพยาบาลใหม่ในห้องผ่าตัด”



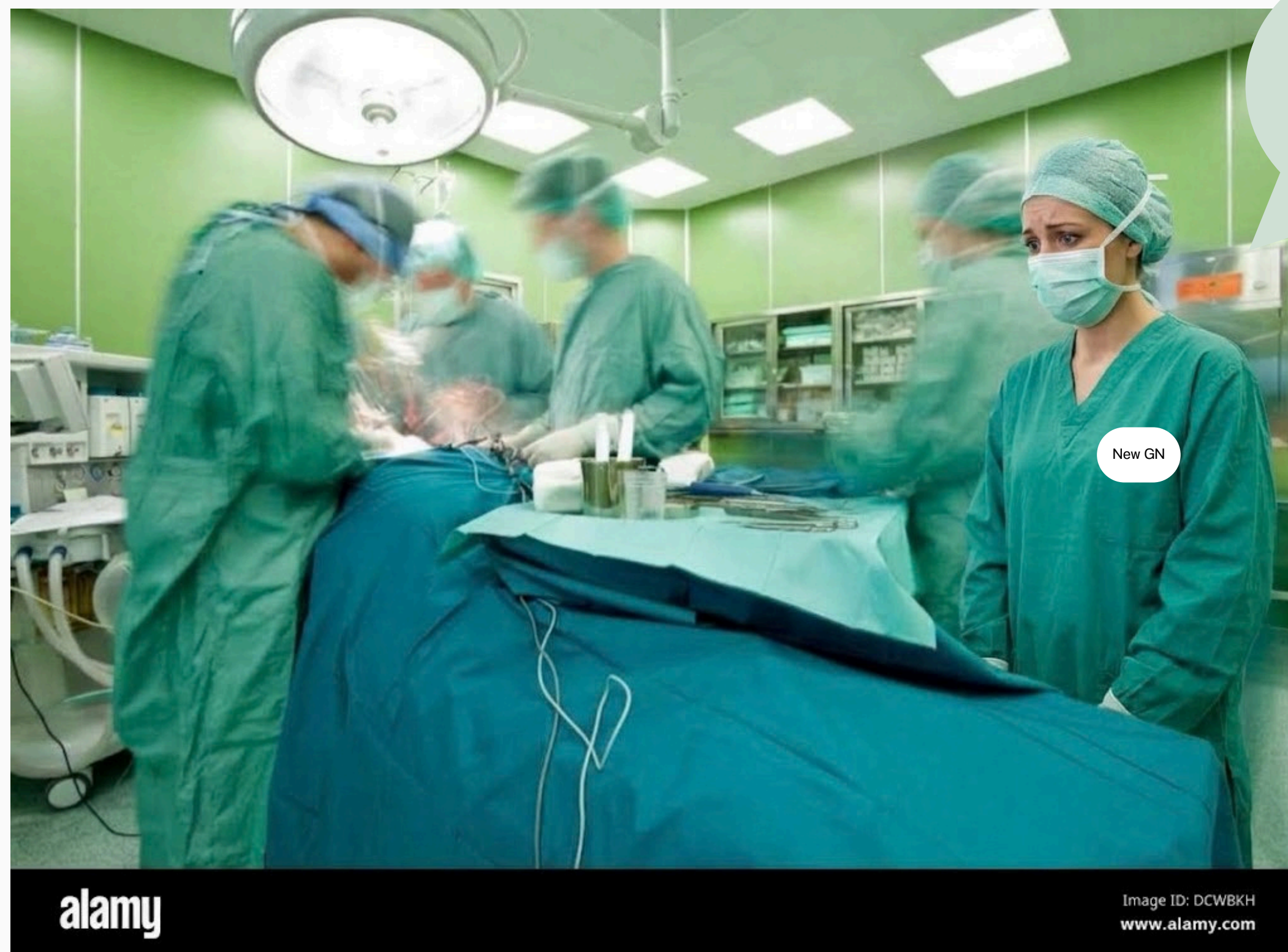
EVOLUTION OF AN OR NURSE

“ถ้าวันนี้...คือวันแรกของคุณ ในห้องผ่าตัด?”





**“คุณคิดว่าพยาบาลใหม่
กังวลเรื่องอะไรที่สุด?”**



ที่มา :<https://www.dreamstime.com/stock-images-busy-surgery-image21741594>



ประสบการณ์การเป็นพยาบาลจบใหม่ที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยง



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2556

ลิขสิทธิ์ในผลงานการค้นคว้าวิทยานิพนธ์นี้เป็นของมหาวิทยาลัย

เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

โดย ผู้ใช้ทั่วไป

are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

ดาวน์โหลดเมื่อ 04/10/2569 12:00

ยุพาพิน ศิริโพธิ์งานและคณะ (2540) ศึกษาเกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ระหว่างการปรับตัวเปลี่ยนเข้าสู่บทบาทวิชาชีพของพยาบาลผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2539 ที่ปฏิบัติงานในแผนกการพยาบาลต่าง ๆ ของโรงพยาบาลรามธิบดีจำนวน 66 คน ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือก่อให้เกิดความเครียดส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.8 เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคล สถานการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหนัก และวิกฤติและความรู้สึกขาดประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคลความรู้สึกขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติมีความเครียดเท่ากันคือร้อยละ 19.7 ส่วนสถานการณ์การปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรและหน่วยงานสถานการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลมีความเครียดร้อยละ 18.2 และ 13.6 ตามลำดับวิธีการเผชิญความเครียดที่พยาบาลจบใหม่ใช้มากที่สุดได้แก่วิธีการเผชิญหน้ากับปัญหาการบรรเทาความรู้สึกเครียดและการจัดการกับอารมณ์ตามลำดับ

จบใหม่ จากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ในช่วง 6 เดือนแรกของการปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลต่าง ๆ สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครจำนวน 117 คน ผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์ที่ทำให้พยาบาลจบใหม่เกิดความเครียดจัดกลุ่มได้ 7 ประเภทคือ การปรับตัวให้เข้ากับบุคลากร, การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล, การขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวให้เข้ากับงานและหน่วยงาน การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน, ความรู้สึกด้านจริยธรรมและการสอไบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านสำหรับวิธีการเผชิญความเครียดพบว่าพยาบาลจบใหม่ใช้วิธีการเผชิญความเครียดทั้ง 3 ด้านคือ การเผชิญหน้ากับปัญหา และการจัดการกับอารมณ์ สรุปได้ว่าประเภทของความเครียดของพยาบาลจบใหม่ คล้ายคลึงกับการศึกษาที่ผ่านมาสถานการณ์ ความเครียดประเภทการปรับตัวเข้ากับบุคลากรมีจำนวนมากที่สุดและวิธีการเผชิญความเครียดใช้วิธีการเผชิญหน้ากับปัญหามากกว่าวิธีการอื่น

“เราจะช่วยน้องได้อย่างไร ?”

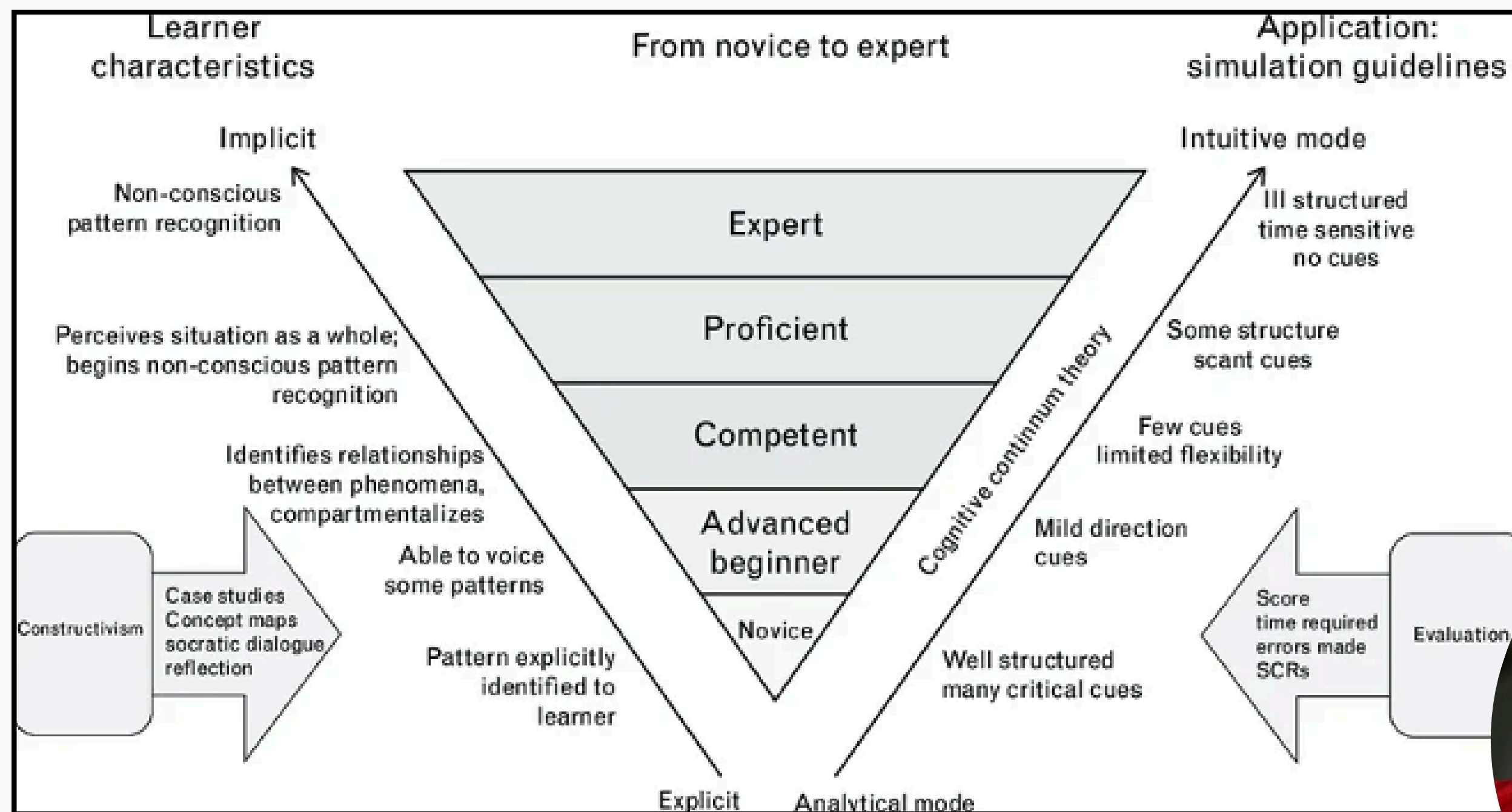


รูปนี้คือใคร ?? เกี่ยวอะไรกับ Preceptor



ที่มา : <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Odysseus-003.jpg>

Benner model หรือ From Novice to Expert Model



ที่มา : <https://nursingthefuture.ca/skills/dr-patricia-benner/>





จากสถานการณ์จริง พี่เลี้ยงช่วยพยาบาลจบใหม่อย่างไร

การฝึกอบรมการนิเทศทางการแพทย์ เรื่อง “การใส่เสื้อกาวน์และถุงมือSterile เข้าช่วยผ่าตัด”
โรงพยาบาลหนองคาย





“คุณเห็นอะไรจาก Clip VDO?”



ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บทบาทพยาบาลที่เลี้ยง บรรยายภาคองค์การกับความตั้งใจ
คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพใหม่ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง เขตสุขภาพที่ 2



วิทยานิพนธ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
ปีการศึกษา 2566
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์

บทบาทพยาบาลที่เลี้ยง เป็นกลไกหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพยาบาลที่จบการศึกษาใหม่ (novice staff-nurses) หรือนักศึกษาพยาบาลที่ทำการฝึกภาคปฏิบัติซึ่งพยาบาลที่จบการศึกษา มักจะประสบกับปัญหาการปรับตัวในการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาระหว่างปีแรกของการทำงาน โดยระบบพยาบาลที่เลี้ยงจะประกอบด้วยพยาบาลที่เลี้ยงซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพอาวุโส ผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางการพยาบาลด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ การบริหาร การศึกษา การวิจัยทางการพยาบาล หรือเคยเป็นที่ปรึกษาทางการพยาบาล มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น (Huybrecht et al., 2011) ทำหน้าที่เสมือนอาจารย์พยาบาลเป็นทั้งผู้สอน ผู้สนับสนุน ผู้ให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ (อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์, 2561) บทบาทพยาบาลที่เลี้ยงช่วยให้พยาบาลใหม่เรียนรู้งานได้เร็วขึ้น เกิดความมั่นใจในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจในงาน ลดความตึงเครียดในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพทั้งต่อพยาบาลใหม่และพยาบาลที่เลี้ยง (จิตาภา รอดโพธิ์ทอง และคณะ, 2559) และการศึกษาที่พบว่า บทบาทพยาบาลที่เลี้ยง ทำให้พยาบาลใหม่ มีความเครียดและวิตกกังวลลดลง มีบทบาทในการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พยาบาลใหม่ มีกระบวนการคิดและการตัดสินใจแก้ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความผูกพัน เกิดความรู้สึกดีต่อกัน (นิสา ทมาภิรัตน์ และอารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2560) รวมทั้งระบบพยาบาลที่เลี้ยง สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงาน และส่งผลให้เกิดการคงอยู่ในงาน (Schuler, 2017) และยังพบว่า กลุ่มที่มีระบบพยาบาลที่เลี้ยงมีความตั้งใจคงอยู่ในงานมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีระบบพยาบาลที่เลี้ยง (อภิรดี นันทศุภวัฒน์ และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, 2562) จากการทบทวนดังกล่าวบทบาทพยาบาลที่เลี้ยงย่อมส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในการทำงานร่วมกันระหว่างพยาบาลที่เลี้ยงและพยาบาลใหม่

ผลของโปรแกรมการสอนแบบต่อสมรรถนะของพยาบาลจบใหม่ที่ยังปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรม

จาชญา มาเมืองชน
คณะพยาบาลศาสตร์

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd>
Part of the Nursing Administration Commons

Recommended Citation

มาเมืองชน, จาชญา, "ผลของโปรแกรมการสอนแบบต่อสมรรถนะของพยาบาลจบใหม่ที่ยังปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรม" (2024). *Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)*. 74534. <https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/74534>

This Thesis is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD) by an authorized administrator of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

ส่งผลต่อการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์พยาบาลจบใหม่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมจำนวน 3 คน จาก 15 คน เมื่อวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ถึงความรู้สึกหลังจากผ่านการดูแล จากพยาบาลที่เลี้ยงครบ 3 เดือนแล้วพบว่า พยาบาลจบใหม่ส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกเครียด เนื่องจากรู้สึกว่าการตนเองถูกคาดหวังจากพยาบาลที่เลี้ยงและหรือผู้ร่วมงาน ว่ามีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นภายหลังผ่านการดูแล ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพยาบาลจบใหม่กลุ่มนี้ยังคงรู้สึกไม่มีความมั่นใจมากพอในการปฏิบัติการพยาบาลเพียงลำพัง หลายครั้งที่ยังคงรู้สึกกังวล แต่ก็ไม่กล้าถามในสิ่งที่ตนเองไม่มั่นใจกลัวโดนตำหนิว่าการอบรมมาแล้วเพราะเหตุใดจึงยังไม่มั่นใจ ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ดังกล่าว สรุปได้ว่า พยาบาลจบใหม่ยังต้องการผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ชี้แนะ ให้คำแนะนำและให้ความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาล ทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันยังสะท้อนผลกระทบที่ชัดเจน โดยพบว่า พยาบาลวิชาชีพลาออกภายใน 1 ปีแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 17-20% ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตเมือง (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2566) สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พยาบาลจบใหม่สามารถปรับตัว และมีสมรรถนะในการทำงานตามท้องถื่นของมอหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมการสอนแบบ (Coaching) เพื่อช่วยลดอัตราการลาออกและเสริมสร้างสมรรถนะอย่างเป็นระบบ จึงสามารถสรุปปัจจัยที่ทำให้พยาบาลจบใหม่พร้อมสมรรถนะตามที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมคาดหวังนั้น เกิดจากข้อจำกัดของรูปแบบการนิเทศของพยาบาล ที่เลี้ยง และปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลจบใหม่ พบว่า ไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพียงลำพัง มีความรู้สึกเครียดซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับรู้ของตนเองยังมีข้อจำกัดด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ และด้านการพัฒนานตนเองและหน่วยงาน เป็นต้น

CASE STUDIES

Australian Journal of Advanced Nursing 42(4) • 2025, 424-2057

Supporting novice nurses in perioperative nursing: A case study of an educational intervention

AUTHORS

KAREN MAHONEY RN ¹SUE HAMMERLING RN, BN, GradDip(PeriopNurs) ¹LINDA CHAPMAN RN ¹JULIE TUCKER RN, PhD ^{1,2}

1. Division of Surgical Specialties and Anaesthesia, Northern Adelaide Local Health Network, Adelaide, South Australia, Australia

2. Clinical and Health Sciences, University of South Australia, Adelaide, South Australia, Australia

CORRESPONDING AUTHOR

KAREN MAHONEY Nurse Consultant, Lyell McEwin Hospital Operating Theatres, Division of Surgical Specialties and Anaesthetics, Northern Adelaide Local Health Network, Haydown Rd, Elizabeth Vale, South Australia, Australia. E: Karen.Mahoney@sa.gov.au

ABSTRACT

Objective: This case study describes the introduction and evaluation of a structured perioperative education program for novice nurses in the theatre setting to address ongoing retention and attrition rates of skilled perioperative nurses.

Background: A proficient and dynamic workforce is essential for specialty areas, including surgical theatre environments. Whilst perioperative nurse education occurs at undergraduate and postgraduate universities, assimilation and further development of skills into the work environment takes time and requires a supportive workplace culture. Lack of support and exposure to clinical experience limits the competency and confidence of novice nurses, which negatively affects retention in specialty areas.

Study Design: Twenty novice nurses underwent a three-month rotation across 14 perioperative specialty areas with an assigned nurse mentor between 2021 and 2024. An educational learning package was developed to track the knowledge, confidence, and capability of novice nurses. Focus group sessions were held every three months, and surveys were administered to assess the overall effectiveness of the program.

Results: Nineteen novice nurses reported increased confidence in their knowledge and overall confidence in the clinical area. Findings demonstrated that the program's structure was a strength, while organisational impacts were the main barrier, including a lack of staff and time pressures identified as barriers. Overall, workplace culture was improved for all staff with improvements in staff retention.

Conclusion: The retention of skilled perioperative staff is essential for best patient outcomes, organisational efficiencies, and a positive work culture and environment. This project has been successful in bridging the theory-practice gap, promoting skill acquisition and professional confidence for NN, whilst enhancing positive workplace culture and staff retention within the study setting. There is a need to review the self-paced learning booklets to enhance the documentation and to show completion by all participants.

Implications for practice: Attrition rates in specialty areas that require a high level of ability, such as the perioperative environment, remain a constant concern for healthcare. This study proves the importance of investing in skill development for novice perioperative nurses through a structured educational program in

Emerging scholar article

Authors

Maeve Hegarty
BSc(Hons) (Nursing)
MCN (Anaesthetic and Recovery Nursing)

Dr Paula Foran
PhD, RN, FACORN, FACPAN, MACN

Corresponding author

Maeve Hegarty
maeveh@utas.edu.au

Perioperative preceptors' education and training: An integrative review

Abstract

Introduction: Against the backdrop of a predicted shortfall of over 70 000 nurses in Australia by 2035, the retention of the perioperative nursing workforce is being challenged by inconsistent preceptor training of novice nurses. The aim of this integrative review is to identify tangible measures that organisations can implement to empower, educate and train perioperative preceptors to grow a skilled perioperative nursing workforce. Enhanced education provided by preceptors may also positively impact patient safety.

Methods: This review aimed to answer the broad question, 'What is known about perioperative preceptor preparation and training?' The initial literature search using specific keywords such as 'preceptor' OR 'mentor' AND 'transition to practice' AND 'perioperative nursing' was conducted across SCOPUS, PubMed and EBSCO databases including, ERIC, Health Source: Nursing/Academic Edition, MEDLINE, MEDLINE Complete and Psychology and Behavioural Sciences Collection. Due to a paucity of primary research conducted specifically on perioperative preceptorship, this was broadened to include preceptorship from general nursing. After applying rigorous inclusion and exclusion criteria, this search yielded 15 relevant research papers. These studies provided both qualitative and quantitative insights into the unique challenges faced by and the support available for preceptorship.

Results: This integrative review identified key factors influencing perioperative nurses' ability to preceptor novice nurses, revealing two overarching themes. The first, 'lack of formalised preceptor training' had three subthemes – learning expectations, feedback and adult learning theories. The second theme was 'workload' and did not have subthemes.

Conclusion: Healthcare organisations must establish clear role definitions for perioperative preceptors and set consistent learning expectations. Moreover, formal training in delivering feedback and adult learning strategies is needed for preceptors to create effective teaching environments. Finally, providing formal education for preceptors, strategies to reduce workload pressures and protected time for preceptors to teach novice perioperative nurses is vital.

Keywords: perioperative preceptor, education, training, workplace learning, mentor new graduate nurse, novice nurse, transition shock, burnout

Introduction

It is widely agreed that well-educated nurses contribute significantly to improving patient outcomes'. Adverse events are reduced when novice nurses have received comprehensive unit-specific workplace training'. When newly graduated nurses are not supported in transitioning to practice, not only is patient safety put at risk but the likelihood of these nurses moving away from clinical nursing is also increased'. The latest reports predict that by 2035 the shortfall in nurses in Australia will

be over 70 000, and the perioperative setting will be no exception'. The aim of this integrative review is to investigate the effectiveness of preceptor programs for novice perioperative nurses.

In this paper 'novice nurses' are defined as any new nursing staff to the operating suite, including experienced nurses new to perioperative practice, undergraduate nursing students and new graduates. Perioperative nursing requires a unique set of specialised competencies that are not routinely taught in the undergraduate curriculum', thus basic training can

This article is licensed under a Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0). Copyright to this work is retained by the authors. DOI: 10.26550/2209-1092.1389



**หากคุณเป็นพี่เลี้ยง
จะช่วยน้องอย่างไร ??**



ประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลรุ่นแซด
ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงในยุคความปกติใหม่
Working Experiences of Generation Z Nurse under Supervision of Nurse Preceptors
in the New Normal Era

นภาพา งามเหมาะ^{1*}, อัจฉริยา ปุณนา¹, กมลเนตร เต็งรัง¹, สุจิตรา มุกดาสนิ¹
Nada Ngammoh^{1*}, Achariya Punna¹, Kamolnate Tengran¹, Sujitra Mookdasanit¹
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา¹
Somdet Phra Boromrajatewi Na Sriracha Hospital^{1*}

(Received: June 17, 2022; Revised: October 15, 2022; Accepted: November 17, 2022)

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลรุ่นแซด ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยง ในยุคความปกติใหม่ ตามมุมมองของพยาบาลรุ่นแซด โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาการตีความ ตามแนวคิดของไฮเด็กเกอร์ ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นพยาบาลรุ่นแซดที่มีวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 – 2555 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานพยาบาลเต็มเวลา อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จำนวน 12 ราย โดยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกเทป การสังเกต และการบันทึกภาคสนาม นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เนื้อหาตามวิธีการของแวน มาเนน ผลการวิจัยพบว่า

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยง ในยุคความปกติใหม่ ตามมุมมองของพยาบาลรุ่นแซด ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) เชี่ยวชาญเครื่องมือใหม่ในชีวิต 2) เชี่ยวชาญความรุนแรงในที่ทำงาน 3) เชี่ยวชาญความไม่สมดุลของชีวิตการทำงาน 4) ต้องการการสนับสนุน 5) ต้องการพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ และ 6) ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้ประโยชน์ทางการพยาบาล: ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า พยาบาลรุ่นแซดให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาตนเอง ดังนั้น ผู้บริหารทางการพยาบาลควรส่งเสริมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อดึงดูดและรักษาพยาบาลรุ่นแซดไว้กับองค์กร

คำสำคัญ: พยาบาลรุ่นแซด, พยาบาลพี่เลี้ยง, ยุคความปกติใหม่, การวิจัยเชิงคุณภาพ

*ผู้ให้การติดต่อ (Corresponding email: tukkatan@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 081-5238272)

พยาบาลรุ่นแซดจะเก่ง สามารถปฏิบัติงานได้ และอยู่ในหน่วยงานอย่างมีความสุข พยาบาลพี่เลี้ยงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อน คอยสนับสนุนพยาบาลรุ่นแซดในการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นนักศึกษามาเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มตัว (Harrison, 2020) ซึ่งพยาบาลรุ่นแซด จะปรับตัวเข้าได้ดีกับพยาบาลรุ่นพี่ที่มีลักษณะเปิดกว้างทางความคิด ยืดหยุ่นในวิธีการ ใจเย็น เข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละรุ่นอายุ มีความเข้าใจรูปแบบการสอนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการพยาบาล (Wongthai & Oumtane, 2020) ซึ่งพยาบาลรุ่นแซด ในการศึกษาต้องการพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะในด้านการสอน สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยวิธีที่เหมาะสม (Chicca & Shellenbarger, 2018b) สามารถให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องเพื่อให้พยาบาลรุ่นแซด สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีสัมพันธภาพที่ดีเพื่อให้เกิดความไว้วางใจกัน เต็มใจรับฟังและพร้อมที่จะช่วยเหลือ พยาบาลพี่เลี้ยงจะเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลให้กับพยาบาลรุ่นแซดเพื่อลดความเครียดในการปฏิบัติงาน และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้พยาบาลรุ่นแซดมีการปรับตัว เกิดความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล และสุดท้ายต้องการพยาบาลพี่เลี้ยงที่เป็นบุคคลต้นแบบของพยาบาลที่ดี จะสามารถช่วยลดหลอมพฤติกรรมของพยาบาลรุ่นแซด เกิดการซึมซับพฤติกรรมที่ดีไว้เป็นบุคลิกภาพของตน เมื่อพยาบาลรุ่นแซดเติบโตขึ้น องค์กรจะมีพี่เลี้ยงที่ดีและมีคุณภาพ



สมรรถนะของ พยาบาลพี่เลี้ยง

- ที่จำเป็น 6 ด้าน -

“สอน สื่อสาร
ดูแล เสริมพลัง
พัฒนาทีม”
♥

1

ด้านการสอน
(Teach/coach)



สอนเป็นขั้นตอน
ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

2

ด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร
(Communication skill)



ฟัง เข้าใจ
พูดชัดเจน สร้างความไว้วางใจ

3

ด้านทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล



ปฏิบัติได้ถูกต้อง ปลอดภัย
เพื่อคุณภาพการพยาบาล

4

ด้านการเสริมสร้างพลังอำนาจ
(Empowerment)



ให้โอกาส สนับสนุน
เพิ่มความมั่นใจ

5

ด้านการให้คำปรึกษา
(Counseling)



รับฟังอย่างเข้าใจ
ช่วยคิด ช่วยแก้ปัญหา

6

ด้านการเป็นผู้นำทีม
(Team leader)



สร้างทีม สื่อสารเป้าหมาย
พัฒนางานร่วมกัน

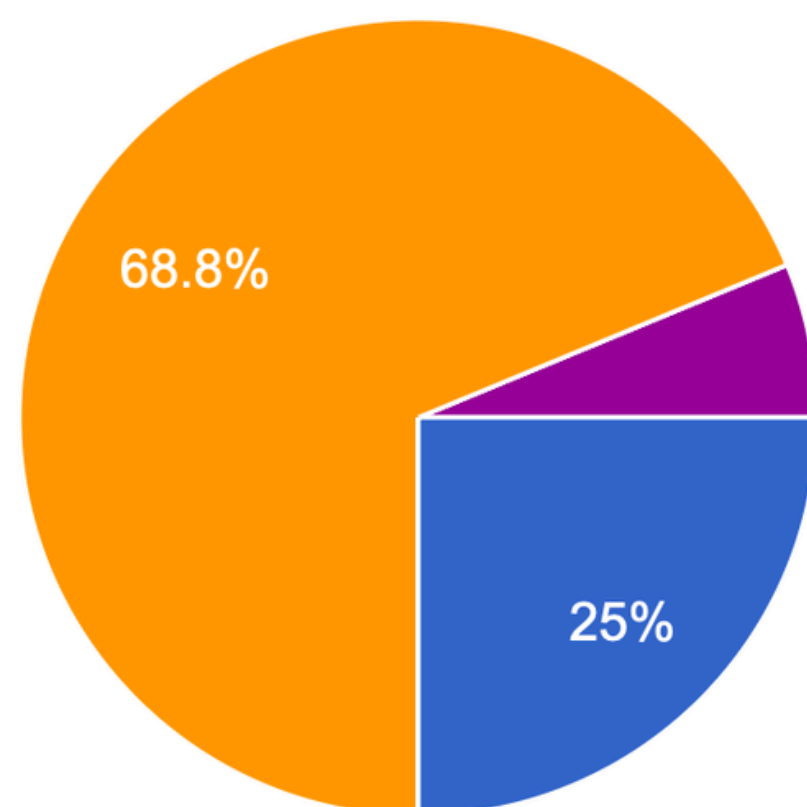


พยาบาลพี่เลี้ยง = ผู้สอน ผู้ฟัง ผู้สนับสนุน ผู้นำทีม ♥



รูปแบบการนิเทศงานพยาบาลจบใหม่ในห้องผ่าตัด

หน่วยงานของท่านมีวิธีการนิเทศงานรูปแบบใด



- พี่เลี้ยงสอนปฏิบัติ แต่ไม่มีการสอนทฤษฎี
- สอนทฤษฎีก่อนทำงาน แต่ไม่มีพี่เลี้ยงสอนปฏิบัติ
- มีพี่เลี้ยงสอนทฤษฎีและปฏิบัติ
- Conference (น้องเรียนรู้อย่าง) ก่อนทำงาน โดยไม่มีพี่เลี้ยงและไม่ได้สอน
- อื่นๆ (ระบุข้อต่อไป)

Training methods



ที่มา : <https://www.geeksforgeeks.org/business-studies/methods-of-training-on-the-job-methods-and-off-the-job-methods/>

ผลของการใช้โปรแกรมการสอนงานสำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นพวรรณ กฤตยภูษิตพงษ์ พย.ม.

กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

บทนำ: ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีพยาบาลที่จบใหม่และพยาบาลย้ายเข้ามาทุกปี ซึ่งพยาบาลที่รับผิดชอบงานสอนยังขาดแนวทางการสอนงานในห้องผ่าตัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับกลุ่มพยาบาลใหม่ ดังนั้นการใช้โปรแกรมการสอนงานพยาบาลห้องผ่าตัด จึงจำเป็นเพื่อเพิ่มทักษะปฏิบัติงานของกลุ่มพยาบาลใหม่ในห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการสอนงานสำหรับพยาบาลจบใหม่และพยาบาลที่ย้ายเข้าปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วัสดุและวิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยประชากร ได้แก่ พยาบาลจบใหม่ และพยาบาลที่ย้ายมาปฏิบัติงานห้องผ่าตัดในปี พ.ศ.2560-2563 จำนวน 23 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา: พยาบาลทั้งหมดเป็นเพศหญิงจำนวน 23 คนอายุระหว่าง 22 ถึง 25 ปี เป็นพยาบาลจบใหม่จำนวน 18 คน และย้ายมาจากที่อื่นจำนวน 5 คน การประเมินก่อนการใช้โปรแกรมการสอนทั้ง 2 กลุ่มเท่ากับ 0.63 และพบว่าคะแนนทักษะการปฏิบัติงาน 15 ขั้นตอนอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 94 และหลังจากใช้โปรแกรมการสอนพบว่า กลุ่มพยาบาลใหม่ทั้งหมดมีค่าคะแนนทักษะสัมพันธ์กับเนื้อหาการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.001$) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจการใช้โปรแกรมการสอนงานในระดับมากที่สุด

สรุป: โปรแกรมการสอนงานเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพสูงซึ่งผลที่ประจักษ์คือพยาบาลใหม่ในห้องผ่าตัดมีทักษะในการปฏิบัติงานถูกต้อง แม่นยำซึ่งมีประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วยสูงขึ้นอีกทั้งความพึงพอใจในรูปแบบการสอนมีผลตอบรับสูง

คำสำคัญ: โปรแกรมการสอนงานห้องผ่าตัด ทักษะการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบของการใช้โปรแกรมการสอนงานสำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (N=23)

ทักษะ	ระดับนัยสำคัญ (P-value)
1.การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด	<.001
2.การเตรียมผิวหนัง	<.001
3.การล้างมือเพื่อการผ่าตัด	<.001
4.การเช็ดมือ	<.001
5.การสวมเสื้อคลุมผ่าตัด	<.001
6.การสวมถุงมือผ่าตัด	<.001

7.การป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดตำแหน่งและผิดประเภทการผ่าตัด	<.001
8.การนับผ้าก๊อช ผ้าซับโลหิต ของมีคมและเครื่องมือ	<.001
9.การใช้เครื่องจีไฟฟ้า	<.001
10.การใช้สายรัดห้ามเลือด	<.001
11.การป้องกันผู้ป่วยตกเตียง	<.001
12.การส่งชิ้นเนื้อส่งตรวจพยาธิวิทยา	<.001
13.การป้องกันการระบุตัวทารกกับมารดาผิดพลาด	<.001
14.การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการจัดทำ	<.001
15.การใช้ Universal Precaution ในห้องผ่าตัด	<.001
ผลเปรียบเทียบทักษะก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม	<.001

จากตารางที่ 2 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการสอนงานสำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยพบว่าหลังเข้าร่วมการสอนพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทั้ง 15 ทักษะดีขึ้นจากก่อนเข้าร่วมการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$)



Tiktok :หมอท็อป Masterpiece Hospital



Tiktok :หมอก๊อป Masterpiece Hospital



**ถ้าย้อนเวลากลับไปวันแรกในห้องผ่าตัด....
คุณอยากมีพี่เลี้ยงแบบไหน ??**



**พยาบาลใหม่ไม่จำเป็นต้องเก่งตั้งแต่วันแรก
แต่ควรมีใครหรือระบบที่ช่วยให้เก่งขึ้นในทุกวันอย่างปลอดภัย**

Thank you.



Mahidol University
Wisdom of the Land

999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พุทรมณฑลสาย 4
ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร : 02 849 6000

อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร.อุษาวดี อัครวิเศษ
อ.นลินทิพย์ นิรันดร์ทวิชัย
พว.อัจฉราวดี สุนทรณเสถณี

สมาชิกกลุ่ม 6

นางสาว ชุติมณฑน์

นางสาว นงนภัส

นางสาว เบญจวรรณ

นางสาว พีรพัชร

นางสาว ภัทรินทร์

นางสาว ยลรดี

ชาญวานิชบริการ

ธรรมชาติ

หอมنان

ชิตชลธาร

พุทธรักษ์

วิชาญโรจน์

รหัสประจำตัว 6911806

รหัสประจำตัว 6911812

รหัสประจำตัว 6911817

รหัสประจำตัว 6911821

รหัสประจำตัว 6911822

รหัสประจำตัว 6911824